抗凝药对比：

低蛋白血症→肝脏代偿合成蛋白质→同时也会代偿合成凝血因子
所以白蛋白<20需要预防性抗凝(肝素、华法林都可)辅以抗板

肝素	增强抗凝血酶活性（间接）、促进 TFPI 释放	肺血栓栓塞、急性冠脉综合征、房颤、肾病综合征等 首先考虑肝素(起效快)最后过渡到华法林(更强)
华法林	拮抗 VitK（抑制 FII、VII、IX、X的合成）	
枸橼酸	螯合 Ca^{2+} 是否有瓣膜病(有瓣膜病用华法林,没有瓣膜病评分,非瓣膜病首选班群)	库存血
达比加群	抑制凝血酶 房颤>48h,危急者用肝素紧急抗凝	肺血栓栓塞、非瓣膜性房颤
利伐沙班	抑制 FX	肺血栓栓塞、非瓣膜性房颤
磺达肝癸钠 替换肝素	抑制 FX（间接）	肺血栓栓塞、急性冠脉综合征
比伐卢定	抑制凝血酶 抗板的基础上抗凝(肝素、华法林都可),PCI后追加比伐卢定	急性冠脉综合征的 PCI 术中

都搞工因子

VS 控心率需要抑制房室结(慢反应细胞)→用二类、四类抗心律失常药

3.**转复并维持窦性心律**　需要打破心房内的折返环→需要搞心房肌(快反应细胞)→用一类抗心律失常药

①**导管消融（优于药物）**，胺碘酮、普罗帕酮、伊布利特等，电复律（伴血流动力学障碍）

两酮对两天

②转复前后是否抗凝——若房颤**持续＞48 小时**（234 夹心饼干）：恢复有效收缩→挤掉附壁血栓 2d

抗凝 3 周	转复→**抗凝 4 周**
危急者可用肝素紧急抗凝	
也可行**食道超声心动图 TEE** 除外心房血栓后	

注意：直接转复可致**脑栓塞**（最常见最严重）、**肠系膜上动脉栓塞**等
外科的题给了房颤的病史,本质就在考肠系膜上动脉栓塞
如一个房颤患者出现了急腹症

AVNRT:腺苷、β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB、胺碘酮、强心苷
(都可以抑制房室结)
β-R拮抗剂和强心苷都能用于:①收缩性心衰+AVNRT②收缩性心衰+房颤
β-R拮抗剂更好

4.**控制心室率**　没有腺苷(半衰期太短,没法持续使用)

①**β-R 拮抗剂（首选）**、非二氢吡啶 CCB（收缩性心衰禁用），伴收缩性心衰当心室率不达标或 β-R 拮抗剂有禁忌症时用强心苷、胺碘酮

②对于无症状且左室收缩功能正常者控制静息心室率＜110；对于症状明显或出现心动过速性心肌病者控制静息心室率＜80、运动时心室率＜110 次/分。达到控心率目标后应行**动态心电图**监测以评估有无心动过缓和心脏停搏

③控心率比维持窦性心律简单、更适合老年人

（六）心电图

①P 波消失、转而形成 **f 波**（比 F 波幅度小、频率快、形态**不一致**，V_1 导联最明显）　V1更靠近右心,I,II导联更典型

②心房率 350-600 次/分（执医考试满分 600 分、360 分及格）

③心律绝对不规则（**RR 间距绝对不等**）

④QRS 波形态多**正常**（除非发生室内差异性传导）



图 3-3-12　心房颤动

房颤波（f 波）频率约 375 次/分，平均心室率约 102 次/分，RR 间期极不规则。

阵发性室上速:150/160-250
房扑(心房率):250-350
房颤(心房率):350-600